WHOシステム思考

WHOシステム思考を、明日の外来でどう使うか

部品から繋がりへ ― 1人の患者から地域までのズームアウト

参考文献

2026-04-09 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

このセッションで持ち帰ってもらう3つ

1. WHO/AHPSR が整理した **3つのフレーム転換** が言える
2. 目の前の1人の患者で **「部品の見方」と「繋がりの見方」** を切り替えられる
3. 自分の診療を、半径を広げて（チーム→外来→地域）眺める **語彙** を持つ

__約束__: 今日の話は、研修1年目の人が明日の外来で1つだけ試せることから始めます。

後半に進むにつれて視野が広がりますが、置いていきません。最後まで一緒に旅をしましょう。

0. なぜ今この話？

- 2026年1月27日、**WHO** と **NHS England** が共催ウェビナーを開催。開催案内は、保健人材を地域・教育・技術・財政・リーダーシップを含むエコシステムの中で捉え、システム思考で考えることを掲げている
- 背景: WHOは **2030年までに世界で1,100万人** の保健医療人材が不足すると推計している（主に低・中低所得国。WHO Health workforce ページ、2026年11月確認）
- 「人を増やす」だけでは解けない問題 → 認識のフレームそのものを見直す、という流れ
- 出典: WHO/AHPSR, Systems thinking for health systems strengthening – changing the frame（2026年2月2日）。2009年の旗艦報告書を振り返る記事

PART 1

症例から入る

症例(架空): 65歳男性、2型糖尿病、HbA1c 8.6%

- 既往: 高血圧、軽度CKD(eGFR 52)
- 内服: メトホルミン1500mg/日、ARB
- 半年前から HbA1c が 7.4 → 8.6 にじわじわ上昇
- 外来では「ちゃんと飲んでます」「食事も気をつけてます」と笑顔
- 体重も変わらない
- **次の一手は?**

  30秒、隣の人と話してみてください。

PART 1・症例から入る

ありがちな「部品の見方」

- HbA1c が高い → 内服を強化する（SGLT2阻害薬を追加？ GLP-1？）
- （補足）CKD合併の2型糖尿病でSGLT2阻害薬は腎保護の面からも検討される（KDIGO 2022、日本糖尿病学会『糖尿病診療ガイドライン2024』）。薬剤選択そのものを否定する話ではなく、**薬を足す前に生活を聞いたか** がここでの問い
- あるいは「服薬アドヒアランスが悪いのでは」と疑う
- 食事指導の紙を渡し直す
- 次回3か月後、また同じ会話

「やるべきこと」のチェックリストはこなしている。けれど、何かが噛み合っていない感じがする。

PART 1・症例から入る

同じ患者を「繋がりの見方」で見直す

外来カルテの欄外に書かれていない情報:

- 半年前に **妻が入院** して以来、夕食は近所のスーパーの惣菜に
- 以前は妻が早朝散歩に付き合っていたが、今は1人だと億劫で出ない
- 通院は本人の運転 → 最近運転に自信がなくなり、診察日を月1回に減らしたいと思っている
- 息子家族は隣市だが、義母の介護で手一杯
- 患者本人は「先生に余計な心配をかけたくない」と思っている

HbA1cの背後には、こういう繋がりがある。

同じカルテ、違う問診

「最近、食事や生活で変わったことってありますか？」

たった1問。ただし、前のスライドの情報を引き出そうとして聞く。

返ってくるのは「いや、特に……」かもしれない。それでも:

- 「奥さん、元気にされてますか？」
- 「散歩、続けてます？」
- 「ここまで運転、しんどくないですか？」

繋がりを意識した問診は、技術というより ”視野” の問題。

PART 2

概念整理

PART 2・概念整理

WHO/AHPSR が整理した3つのフレーム転換(2009年の報告書)

	これまで(部品)	これから(繋がり)
1. 何を見るか	部品 (parts)	繋がり (connections)
2. どう介入するか	管理 (control)	学習 (learning)
3. どう成果を測るか	ブラックボックス的な評価(結果だけを見る)	文脈と過程の説明

出典: Systems thinking for health systems strengthening – changing the frame, WHO/AHPSR, 2026年2月2日(2009年の報告書 de Savigny & Adam 編 の意義を3点で整理した記事)。表の日本語は本教材での言い換え

転換1: 部品から繋がりへ

- **部品**: HbA1c, 血圧, eGFR, BMI ……単独の数値
- **繋がり**: 数値どうしの関係、数値と生活の関係、患者と家族の関係、患者と医療者の関係

「数値は嘘をつかないが、数値だけ見ていると患者を見失う」

家庭医にとっては当たり前のことを、WHO/AHPSR が保健システム全体について言い直した、と捉えると分かりやすい。

転換2: 管理から学習へ

- **管理(処方に近い姿勢)**: 「こうしなさい」と告げるモード。プロトコル通り、ガイドライン通り
- **学習**: 「やってみてどうだったか」を一緒に振り返るモード

これは「ガイドラインを捨てよう」という話ではない。

ガイドラインは ”**最初の仮説**” として使い、次回外来は ”**前回の仮説の検証**” に使う、というイメージ。

*PDCA を、医療者だけでなく **患者と一緒に回す** 感じ。*

転換3: 結果の評価から、文脈と過程の説明へ

- **アウトカム測定**: HbA1c が下がったか、再入院率が減ったか
- **文脈と過程の説明**: なぜ下がったのか / なぜ下がらなかったのか、その人の生活の中で何が起きているか

アウトカム測定をやめるわけではない。

測定で「何が起きたか」、文脈理解で「なぜ起きたか」を補う。どちらか一方では片手落ち。

3つの転換を、さっきの症例に当てはめると

転換	この症例での実装
部品→繋がり	HbA1c単独でなく、配偶者入院・社会的孤立・通院困難の連鎖を見る
管理→学習	「散歩を再開しましょう」ではなく「次回までに何が起きたか教えてください」
測定→文脈	次回 HbA1c が下がっても上がっても、「なぜ？」を聞ける関係

PART 3

自分の診療への適用

明日の外来で1つだけ試せること

外来の1人目の患者の最後に、こう聞いてみる:

> *「最近、生活で何か変わったことはありますか？」*

ポイント:

- カルテのキーワードを埋めるためではなく、**繋がりを探すために** 聞く
- 返ってきた情報は、無理に問題リストに統合しなくていい。「気にしている」と相手に伝わるだけで十分
- 慣れてきたら「家族で何か変化はありますか？」「仕事はどうですか？」とバリエーションを増やす

PART 3・自分の診療への適用

ふりかえりの型 — 自分の診療に学習ループを入れる

外来終わりに30秒、こう問う:

1. 今日の患者で、**繋がりを見落としていた** 可能性があるのは誰か?
2. その繋がりは、**次回どう聞けば** 浮かび上がりそうか?
3. 自分が気づけたのは、**何のおかげ** だったか?

メモは要らない。考える習慣だけでいい。

これが「管理から学習へ」の、自分自身への適用。

PART 4

次の半径へ ── チームと外来導線

半径を広げる: チーム回診のシステム視点

- カンファレンスで症例を出すとき、**社会背景の1スライド** を必ず付ける文化にできるか?
- 看護師・MSW・薬剤師が見ている ”繋がり” は、医師が見ている ”部品” を補完する宝の山
- 「あの人の奥さん、最近来てないですよね」という看護師の一言が、HbA1c の謎を解くことがある

チーム = 1人の医師では見えない繋がりを束ねる装置

外来導線を「学習ループ」に変える小さな仕掛け

- 予約システムに「前回の宿題」欄を追加できないか
- 受付の問診票に「最近の変化」を書く欄を追加してみる
- 検査結果説明のとき、数値の前に「前回からの間に何がありましたか？」を聞く順番にする

どれも今日明日には変えられないかもしれない。

でも、「これは自分が将来触れる場所だ」と思って外来を歩くと、見え方が変わる。

PART 5

自院・地域に持ち帰る

自分の診療所/病院をシステムとして見る

- 「なぜうちの外来は毎週金曜の午後がパンクするのか」
- 「なぜリハビリ依頼の戻りが遅いのか」
- 「なぜ ACP の話し合いが一向に進まないのか」

これらは、**個人の努力不足ではなく、システムの構造** の問題であることが多い。

システム思考は、こういう問いに「誰が悪い」ではなく「**どこに繋がりの詰まりがあるか**」で答える道具を提供する。

マクロ文脈: 2030年に1,100万人不足の見通し

- WHOの推計では、人材の不足は今後も続く（主に低・中低所得国）。人を増やす努力と並んで、既存の人材の力を生かす視点が要る
- 既存の人材が **繋がりを束ねる** 力を持つことが、その一つの手がかり
- 家庭医療・総合診療という職種は、まさにこの文脈に近い位置にいる

ウェビナーの開催案内は、リーダーに「専門家から協働の促進者へ」という視点の転換を問いかけている。

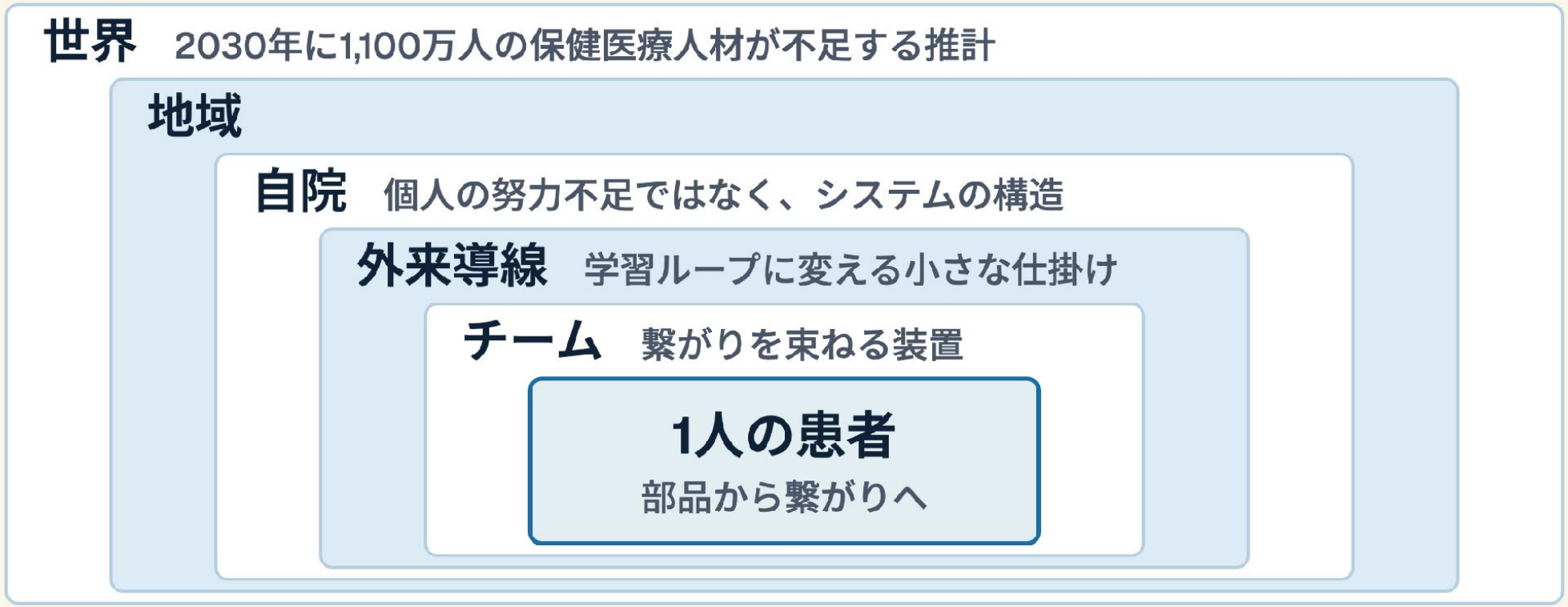
家庭医にとっては新しいアイデンティティではなく、

***すでにやっていることに世界が目を向け始めた** という話。*

PART 5・自院・地域に持ち帰る

ズームアウト

1人の患者から世界まで



出典: WHO Health workforce ページ（2026年11月確認）

今日のまとめ

1. WHO/AHPSR は **3つのフレーム転換** を整理している（2009年報告書、2026年に再紹介）
   （部品→繋がり / 管理→学習 / 結果だけの評価→文脈と過程の説明）
2. それは **明日の外来の1問** から実装できる
   （「最近、生活で変わったことは？」）
3. 半径を広げると、**チーム → 外来導線 → 自院 → 地域 → 世界** の話になる
4. 家庭医療科にいる私たちは、**この潮流の追い風** を受けている

明日からの宿題（任意）

- 1人の患者で「繋がりを意識した1問」を試す
- カンファで症例を出すとき、社会背景の1行を必ず添える
- 外来終わりに30秒、「今日見落とした繋がりはなかったか」を自問する

うまくいかなくてもOK。**やってみて気づいたことを次回シェア** してください。それが「学習ループ」です。

出典

主出典: WHO/AHPSR. Systems thinking for health systems strengthening – changing the frame. 2026年2月. https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/02-02-2026-systems-thinking-for-health-systems-strengthening-changing-the-frame
副出典: WHO. Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce Strengthening (Webinar). 2026年1月27日. https://www.who.int/news-room/events/detail/2026/01/27/default-calendar/embracing-complexity--systems-thinking-for-health-workforce-strengthening
WHO. Health workforce(推計: 2030年に1,100万人不足). https://www.who.int/health-topics/health-workforce
KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in CKD. Kidney Int 2022;102(5S):S1-S127
背景文献: ドネラ・メドウズ『世界はシステムで動く』, ピーター・センゲ『学習する組織』

参考文献

参考: もう一歩深めたい人へ

- **複雑適応系（Complex Adaptive System, CAS）**の入門資料
- **ドネラ・メドウズのレバレッジポイント論**（12段階）
- **WHOの保健システム6つのビルディングブロック**
- **『Friday Night at the ER』**— システム思考教育用シミュレーションゲーム

興味が湧いたら、Slack #learning にひとこと投げてください。文献紹介します。